

GG19 按险种分类的盈亏平衡分析

GG19 的168例中确实存在 **两种险种**，对应不同的 DRG 标杆费用：

险种	代码	例数	占比
职工医保	310	18	11%
城乡居民医保	390	150	89%

险种310（职工医保）— DRG 标杆费 ≈ 6,107 元

特征： 标杆费高且稳定（6,067~6,144），仅 18 例，盈亏状况相对较好。

医疗费区间	例数	盈利	亏损	盈利占比	平均盈亏
4,000~5,000	3	3	0	100%	+1,614
5,000~5,500	2	2	0	100%	+696
5,500~6,000	5	5	0	100%	+380
6,000~6,500	1	0	1	0%	-292
6,500~7,000	4	0	4	0%	-533
7,000~8,000	3	0	3	0%	-1,206

盈亏分界线： ≈ 6,000 元

控制目标：

- **绝对安全：医疗费 < 6,095 元**（P25 标杆费）
- 盈利病例医疗费范围：4,242 ~ 5,982 元（全部在 6,000 以下）

- 亏损病例医疗费范围：6,387 ~ 7,408 元（全部在 6,000 以上）
- 当前平均医疗费 5,991 元，基本达标，只差 -116 元/例，再将医疗费降低 100 元左右即可全面盈利

险种390（城乡居民医保）— DRG 标杆费 ≈ 5,447 元

特征：标杆费 低 且 每月不同，是亏损的主力（150 例占 89%）。

月度 DRG 标杆费波动：

月份	例数	DRG 标杆费	平均医疗费	盈亏均值
1月	37	5,444	6,271	-827
2月	54	5,786	5,934	-148
3月	59	5,139	6,155	-1,015

关键发现：该险种的 DRG 标杆费每月不同，且浮动较大（5,139 ~ 5,786）。其中 2 月的标杆费最高（5,786），亏损最小；3 月的标杆费最低（5,139），亏损最严重。

医疗费区间	例数	盈利	亏损	盈利占比	平均盈亏
4,000~5,000	4	4	0	100%	+1,083
5,000~5,500	35	25	10	71%	+238
5,500~6,000	42	9	33	21%	-277
6,000~6,500	26	0	26	0%	-857
> 6,500	43	0	43	0%	-1,700+

盈亏分界线：≈ 5,500 元（标杆费的波动中心）

控制目标：

- 绝对安全：医疗费 < 5,139 元（最低月标杆费，P25 水平）
- 合理目标：医疗费 < 5,447 元（平均标杆费）

- 盈利病例医疗费范围：4,362 ~ 5,757 元（平均 5,291）
- 亏损病例医疗费范围：5,181 ~ 8,702 元（平均 6,380）
- 当前平均医疗费 6,104 元，需缩减约 657 元/例

对比汇总

指标	险种310（职工医保）	险种390（城乡居民医保）
例数	18	150
平均 DRG 标杆费	6,107 元	5,447 元
盈亏分界线	≈ 6,000 元	≈ 5,500 元
控费目标（不亏损）	< 6,000 元	< 5,500 元
当前平均医疗费	5,991 元	6,104 元
需缩减	~116 元/例	~657 元/例
盈利比例	56%	25%

核心结论

- GG19 的控费目标因险种而异：
- 职工医保（310）：医疗费控制在 6,000 元以下 即可基本不亏损，当前已接近达标
 - 城乡居民医保（390）：医疗费需控制在 5,500 元以下 才能不亏损，当前超额约 657 元/例，是亏损重灾区
- 重点改善方向： 险种390（占89%）的医疗费需从 6,104 元压降到 5,500 元以下，核心路径仍是缩短住院天数至 7 天以内（目前该险种 > 7 天的病例占 79%）。